**MAKALAHaaaaa**

# PROGRAM PENANGANAN MASALAH GIZI HIPERTENSI

Dalam Rangka Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Manajemen Program Gizi

Semester Gangsal Tahun Ajaran 2025/2026


**Disusun oleh :**

**Kelompok 2**

| | |
|---|---|
| **Sekar Ayu** | **061221001** |
| **Yasmin** | **061221005** |
| **Bunga Aprilia** | **061221019** |
| **F. Hana Adiptha** | **061221024** |
| **Siti Alfiyatur Rohmaniyah** | **061221027** |

**PROGRAM STUDI SARJANA GIZI**

**FAKULTAS KESEHATAN**

**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**UNGARAN**


**2025**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul *"Program Penanganan Masalah Gizi Hipertensi"* tepat pada waktunya. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Program Gizi sekaligus menambah wawasan mengenai peran gizi dan program kesehatan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular, khususnya hipertensi.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, makalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, rekan-rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penyusunan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Besar harapan penulis, makalah ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penanganan gizi dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi di masyarakat.

Ungaran, September 2025
Penulis

# HALAMAN PENGESAHAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang selalu mendapat perhatian didunia, pasalnya penyakit hipertensi ini merupakan salah satu penyebab morbiditas terbesar didunia. Penderita hipertensi diperkirakan mencapai 1,5 miliar pada tahun 2025 daritotal seluruh penduduk dunia dan mortalitas yang disebabkan dapat mencapai 9,4 juta individu. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) prevalensi hipertensi sebesar 34,1%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari sebelumnya yang dilakukan oleh Riskesdas pada tahun 2013 yakni sebesar 25,%. Dari sekian banyak penderita hipertensi tersebut di Indonesia, diperkirakan hanya sebanyak 1/3 kasus hipertensi yang dapat di diganosis,sisanya tidak terdiagnosis.

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi dengan tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Tekanan darah pada manusia secara alami berfluktuasi setiap harinya.Tekanan darah tinggi dianggap bermasalah apabila tekanan tersebut bersifat persisten. apabila tidak terkontrol atau tidak diberi perhatian khusus dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti bila mengenai jantung kemungkinan dapat terjadi infark miokard, jantung koroner, gagal jantung kongestif, bila mengenai otak terjadi stroke, ensefalopati hipertensif,dan bila mengenai ginjal terjadi gagal ginjal kronis,sedangkan bila mengenai mata akan terjadi retinopati hipertensif (Tika, 2021).

Banyak faktor yang berperan dalam terjadinya hipertensi diantaranya faktor risiko yang tidak terkendali dan faktor risiko yang dapat dikendalikan. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol seperti faktor keturunan, jenis kelamin,ras dan usia. Sedangkan faktor risiko yang dapat dikendalikan adalah obesitas, kurang olah raga atau aktivitas fisik, merokok, minum kopi,sensitivitas natrium, kadar kalium rendah alkohol, stres, pekerjaan, pendidikan dan pola makan (Rahmadhani, 2021).

Peran gizi dalam hipertensi sangat erat kaitannya dengan pola makan, di mana konsumsi garam berlebihan, makanan tinggi lemak jenuh, rendah serat, serta kurangnya asupan buah dan sayur menjadi faktor risiko utama terjadinya hipertensi. Kebiasaan masyarakat yang cenderung mengonsumsi makanan instan, cepat saji, dan olahan tinggi natrium semakin memperburuk kondisi ini, sehingga pencegahan primer melalui penerapan pola makan sehat dan gizi seimbang sangat diperlukan. Upaya tersebut perlu ditunjang dengan peran petugas kesehatan yang memberikan edukasi gizi, mendorong perubahan gaya hidup, serta melakukan deteksi dini melalui skrining tekanan darah secara rutin. Pemantauan tekanan darah dan pendampingan dalam penerapan pola makan sehat menjadi langkah penting untuk mencegah hipertensi sejak dini maupun mengendalikan kondisi pada penderita agar tidak menimbulkan komplikasi. Dengan demikian, kolaborasi antara edukasi gizi dan peran aktif petugas kesehatan menjadi kunci dalam menekan prevalensi hipertensi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Noorhidayah et al, 2025).

Dalam upaya mengendalikan hipertensi, program penanganan gizi di masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk menurunkan prevalensi penyakit, meningkatkan kesadaran gizi seimbang, sekaligus mencegah komplikasi. Salah satu

bentuk nyata adalah Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, di mana penderita hipertensi mendapatkan edukasi gizi, pemantauan kesehatan rutin, konseling, serta dukungan untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, terdapat pula Posyandu Lansia yang menjadi wadah pelayanan kesehatan bagi kelompok usia lanjut, termasuk pemeriksaan tekanan darah, penyuluhan gizi, serta pendampingan dalam memperbaiki pola makan sehari-hari. Melalui program-program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan medis, tetapi juga informasi praktis mengenai cara mengatur pola makan, seperti membatasi garam, mengurangi konsumsi lemak jenuh, dan memperbanyak asupan buah serta sayur. Dengan adanya dukungan dari tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, program gizi ini diharapkan mampu menjaga tekanan darah tetap terkendali, menekan angka komplikasi akibat hipertensi, meningkatkan kualitas hidup penderita, serta mengurangi beban kesehatan secara menyeluruh.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya penanganan masalah gizi terkait hipertensi agar dapat menurunkan angka kejadian dan mencegah komplikasi penyakit?
2. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya lansia, dalam menerapkan pola makan sehat dan gaya hidup yang mendukung pengendalian hipertensi?
3. Bagaimana peran program berbasis masyarakat seperti Prolanis dan Posyandu Lansia dalam pemantauan tekanan darah, edukasi gizi, serta peningkatan kualitas hidup penderita hipertensi?
4. Apa strategi yang efektif untuk melibatkan tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program penanganan hipertensi berbasis gizi?

C. Tujuan Program

1. Tujuan Umum

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan masalah gizi hipertensi dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berbasis program komunitas.

2. Tujuan Khusus

a. Menurunkan prevalensi hipertensi melalui perubahan pola makan sehat dan gizi seimbang.
b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hubungan gizi dengan hipertensi.
c. Melakukan deteksi dini, pemantauan tekanan darah, dan konseling gizi secara rutin di masyarakat.
d. Memberikan edukasi dan pendampingan bagi penderita hipertensi untuk mencegah komplikasi.
e. Mengoptimalkan peran Posyandu Lansia dan Prolanis sebagai wadah pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

D. Manfaat

1. Bagi Individu

a. Membantu penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah melalui pendampingan gizi dan gaya hidup sehat.

b. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pola makan rendah garam, rendah lemak jenuh, dan kaya serat
c. Mencegah timbulnya komplikasi akibat hipertensi.

2. Bagi Masyarakat
a. Meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga kesehatan melalui penerapan gizi seimbang.
b. Mengurangi beban kesehatan masyarakat dengan menekan angka kejadian hipertensi.
c. Memberikan wadah pelayanan kesehatan berkesinambungan bagi lansia dan kelompok berisiko.

3. Bagi Tenaga Kesehatan dan Institusi
a. Memudahkan pelaksanaan pemantauan tekanan darah dan status gizi masyarakat secara terstruktur.
b. Mendukung program pemerintah dalam pengendalian penyakit tidak menular.
c. Menjadi model pengembangan program gizi berbasis komunitas yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Tinjauan teori

gghjuik

# BAB III

# PEMBAHASAN

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat di Kabupaten Semarang. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi hipertensi di Kabupaten Semarang mencapai 40,69%, angka yang cukup tinggi dibandingkan prevalensi nasional yaitu 34,1%. Di Kecamatan Bringin sendiri, hipertensi juga menjadi perhatian. Kondisi ini erat kaitannya dengan pola makan masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat masih sering mengonsumsi lauk pauk tinggi garam seperti ikan asin, ikan teri, mie instan, dan kerupuk. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena jenis makanan tersebut relatif lebih murah, tahan lama, dan mudah diperoleh dibandingkan sumber protein segar seperti ikan atau daging (Ariani et al, 2018). Walaupun sayur tetap menjadi bagian dari menu harian, tingginya asupan garam dari lauk pendamping menjadikan risiko hipertensi.

Upaya penanganan hipertensi di Bringin telah dilakukan melalui program yang dijalankan oleh Puskesmas dengan kader kesehatan. Posyandu Lansia menjadi wadah utama pemantauan kesehatan dengan kegiatan pengukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut serta pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, dan kolestrol. Selain itu, terdapat Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis yang menjadi salah satu fokus pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan diabetes. Program ini tidak hanya mencakup pemeriksaan rutin, tetapi juga konsultasi, penyuluhan, hingga kegiatan senam bersama (Anggraeni et al, 2025). Kehadiran program ini menjadi penting karena mampu memberikan edukasi dan kontrol kesehatan yang lebih terarah kepada masyarakat yang rentan mengalami penyakit tidak menular. Partisipasi masyarakat dalam program ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebenarnya cukup baik di wilayah Bringin, meskipun masih ada kendala dalam praktik sehari-hari.

Permasalahan utama yang masih dihadapi masyarakat Bringin adalah keterbatasan ekonomi yang membuat mereka sulit lepas dari konsumsi lauk tinggi garam. Edukasi gizi yang diberikan melalui Posyandu maupun Prolanis memang cukup diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka mulai memahami bahaya hipertensi, mengenali tanda-tandanya, dan mengetahui anjuran untuk mengurangi makanan tinggi garam serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diikuti perubahan pola makan karena daya beli keluarga terbatas. Misalnya, masyarakat mengetahui bahwa daging ayam atau ikan segar lebih sehat dibandingkan ikan asin, tetapi kondisi finansial membuat mereka lebih memilih membeli lauk yang lebih murah dan tahan lama. Situasi ini memperlihatkan bahwa perilaku konsumsi bukan semata-mata ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi (Subair, 2023).

Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka hipertensi di Bringin adalah memperkuat pendekatan gizi berbasis komunitas dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang murah, mudah didapat, namun tetap bergizi (Saragih et al, 2025). Potensi pangan lokal yang melimpah seperti singkong, jagung, pisang, dan sayuran hijau dapat dimanfaatkan lebih maksimal sebagai sumber energi, serat, dan vitamin. Begitu juga dengan ikan lele yang dapat menjadi sumber protein dengan harga lebih terjangkau dibandingkan daging ayam atau sapi. Diversifikasi lauk dengan bahan pangan lokal rendah garam juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada ikan asin, ikan teri, mie instan, dan kerupuk (Widowati dan Nurfitriani, 2023). Penyuluhan yang diberikan melalui pertemuan warga akan lebih efektif jika disertai contoh nyata, misalnya praktik mengolah

singkong atau jagung menjadi lauk sehat yang lezat dan rendah garam. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah tangga.

Dengan dukungan tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta partisipasi pemerintah desa, program penanganan hipertensi di Bringin dapat berjalan lebih optimal. Apabila strategi berbasis pangan lokal ini dikombinasikan dengan edukasi yang kontekstual dan disampaikan secara konsisten, maka perubahan pola makan yang lebih sehat dapat diwujudkan. Harapannya, prevalensi hipertensi di Bringin akan menurun secara bertahap, kualitas hidup masyarakat meningkat, serta beban kesehatan akibat penyakit tidak menular dapat berkurang. Dengan kata lain, keberhasilan menekan kasus hipertensi di Bringin tidak hanya ditentukan oleh program kesehatan formal dari Puskesmas, tetapi juga sinergi antara masyarakat, kader, dan pemerintah desa dalam membangun pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.